

순천향대학교 천안병원

척수강내 항암요법

(ITx, Intrathecal Chemotherapy)

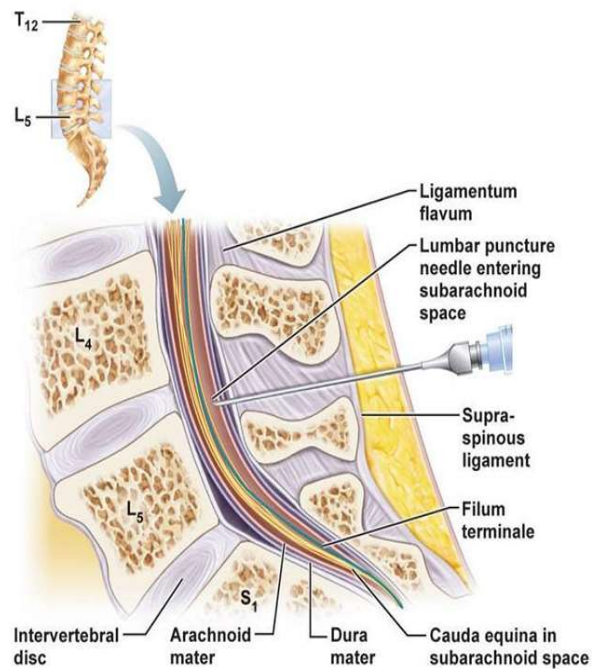
척수강내 항암요법 (ITx, Intrathecal Chemotherapy)

일반적인 정맥 항암제는 우리 몸의 뇌혈관장벽(BBB, Blood-Brain Barrier)에 막혀 뇌와 척수(중추신경계)까지 잘 통과하지 못합니다.

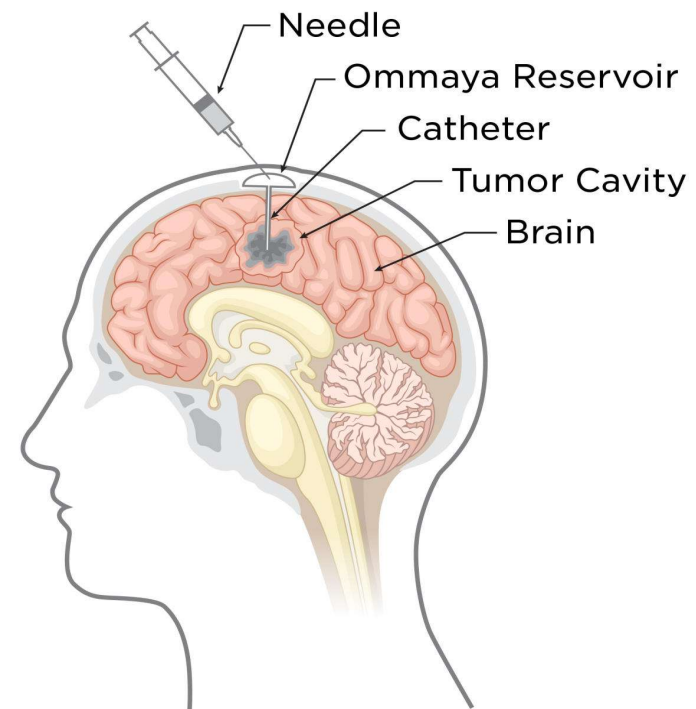
따라서 중추신경계(CNS)로 암세포가 침범하는 것을 예방하거나 치료하기 위해, 뇌척수액이 흐르는 요추 사이 척수강(지주막하 공간)으로 항암제를 직접 투여하는 치료법입니다. 주요 대상은 백혈병, 림프종 환자 및 일부 고형암의 뇌척수막 전이 환자 등입니다.

척수강내 항암요법 (ITx, Intrathecal Chemotherapy)

① Lumbar puncture (요추천자)



② Ommaya reservoir (오마야 저류조)



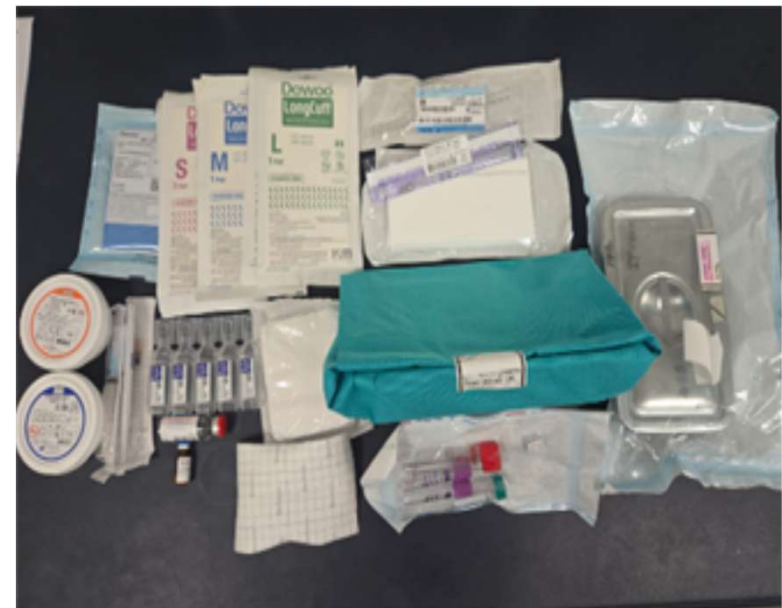
척수강내 항암요법 (ITx, Intrathecal Chemotherapy)

1. 동의서

- 요추천자 검사 동의서, 척수강 내 약물 투여 Checklist, 시술 전 점검표,
- 첫 약물 투여 시 항암화학요법 동의서

2. 준비 물품

Set 내부 (spinal tapping set or aspiration set)	Set 외부
① 알코올 볼 ② 베타딘 볼 많이 ③ 1cc 주사기 1개 ④ 18G needle 1개 ⑤ 5cc 주사기 1개 ⑥ 3cc 주사기 1개 ⑦ ★25G needle 1개 ⑧ spinal needle 23G 1개 ⑨ 30매 거즈 1개 ⑩ 멸균소공포	① 소독된 CSF 검체 tube 1 set (처음 시행하는 경우는 2set 준비) ② 멸균장갑 사이즈 별 2개씩(S size는 4개) ③ 슈퍼픽스 3칸 3장 ④ s-pad 1개 ⑤ 멸균 생리식염수 20ml 10ea ⑥ 전 처치 약물(코티솔, 리도카인 vial로 준비) ⑦ 항암 프로토콜 출력 ⑧ CSF 검체 바코드 출력



척수강내 항암요법 (ITx, Intrathecal Chemotherapy)

3. 추가 여유분 준비

- 1) spinal manometer 1ea, spinal needle 20~23G 각 2ea,
- 2) 소독된 CSF 검체 tube 1set, 10cc 18G 1개,
- 3) 5cc 주사기 1개, 25G needle 1개(25G 38), 30매 거즈 1개

4. 배상병 교수님

- 1) 소독가위
- 2) Bowel D-set
- 3) IV 파란색 수액 SET
- 4) 3way
- 5) 플라스틱 의자 2개



척수강내 항암요법 (ITx, Intrathecal Chemotherapy)

5. 시행방법

1) 환자 확인 및 자세 잡기

환자에게 목적 설명 후 측와위(옆으로 누운 자세)를 취하게 하고,

새우등 자세(등을 둥글게 구부려 무릎을 가슴에 붙이고 턱을 당긴 자세)를 만들어 요추 간격을 최대한 넓혀줍니다.

2) 시술 부위 소독 및 마취

3) 천자 및 뇌척수액 배액

4) 항암제 주입

주입할 항암제의 양은 배액해낸 뇌척수액의 양을 넘지 않도록 하며,

압력변화를 최소화하기 위해 매우 천천히 약물을 주입합니다.

5) 바늘 제거 및 드레싱

척수강내 항암요법 (ITx, Intrathecal Chemotherapy)

6. 사용되는 약제

- 1) Methotrexate (MTX) : 가장 흔하게 사용됨
- 2) Cytarabine (Ara-C) : 단독 또는 liposomal 형태로 사용
- 3) Hydrocortisone : 염증 반응 감소를 위해 병용

7. 시행 후 간호(Post care)

- 1) 앙와위(Supine position) 유지가 가장 중요★합니다.
- 2) 베개를 베지 않고 똑바로 누운 자세로 6시간동안 ABR 유지해야합니다.
- 3) 머리를 들거나 일어서지 않도록 강력히 교육합니다.
- 4) (천자 부위로 뇌척수액이 유출되면 뇌압이 떨어져 극심한 두통이 발생하기 때문입니다.)
- 5) 활력징후 및 신경학적 상태 모니터링 (하지의 감각 이상, 저림, 운동 능력 저하 등)
- 6) 부작용 관찰 (심한 두통, 오심/구토, 경부강직, 고열 등 즉시 의사에게 보고)
- 7) ABR 종료 시 천자 부위 관찰 필요 (추가 혈액 또는 CSF 등 oozing 확인)

감사합니다